

Rách Tầng Sinh Môn Độ Ba và Độ Bốn

Thông tin cho bệnh nhân · Rách nặng khi sinh con — phẫu thuật và phục hồi

WARWIKI

Trong khi sinh con qua đường âm đạo, vùng tầng sinh môn (giữa âm đạo và hậu môn) có thể bị rách. Rách **độ ba** lan vào cơ vòng hậu môn; rách **độ bốn** xuyên qua cơ vòng vào niêm mạc trực tràng. Cả hai được gọi chung là **tổn thương cơ vòng hậu môn khi sinh (OASIS)**. Vết rách được phẫu thuật ngay sau sinh, và với chăm sóc đúng cách, hầu hết phụ nữ đều hồi phục tốt.

Điều Đã Xảy Ra

Cơ vòng hậu môn là vòng cơ giữ khí và phân. Rách nặng ảnh hưởng đến cơ này, vì vậy việc phẫu thuật cẩn thận và theo dõi sau đó rất quan trọng — để bảo vệ khả năng kiểm soát ruột lâu dài. Vết rách không phải do bạn làm sai điều gì.

Ca Phẫu Thuật

Phẫu thuật được thực hiện ngay sau sinh, thường trong phòng mổ hoặc phòng sinh với gây mê phù hợp (thường là tê tùy sống hoặc gây tê ngoài màng cứng). Bác sĩ phẫu thuật tái tạo các lớp mô **từng lớp một** — nối lại cơ vòng hậu môn, và với rách độ bốn, khâu thêm niêm mạc trực tràng — bằng chỉ tự tiêu. Bạn sẽ được dùng kháng sinh và hướng dẫn kiểm soát đau và chăm sóc ruột.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tầng sinh môn

Vùng giữa âm đạo và hậu môn.

OASIS

Tổn thương cơ vòng hậu môn khi sinh — rách độ ba hoặc độ bốn.

Cơ vòng hậu môn

Vòng cơ kiểm soát khí và phân.

Độ ba

Rách lan vào cơ vòng hậu môn.

Độ bốn

Rách xuyên qua cơ vòng vào niêm mạc trực tràng.

Thuốc làm mềm phân

Thuốc giữ phân mềm để tránh rặn khi đang lành.

Vật lý trị liệu sàn chậu

Liệu pháp phục hồi sức mạnh và phối hợp cơ sau khi lành.

TÔI CÓ BỊ DI CHỨNG LÂU DÀI KHÔNG? Hầu hết phụ nữ hồi phục tốt và lấy lại khả năng kiểm soát bình thường. Một số ít có thể gặp khó khăn khi giữ khí hoặc phân, vì vậy theo dõi và tập vật lý trị liệu sàn chậu rất quan trọng — và có các phương pháp điều trị hiệu quả nếu triệu chứng vẫn còn. Hãy báo cho nhóm chăm sóc về bất kỳ tình trạng rò rỉ nào thay vì chờ đợi.

Lành Thương & Tự Chăm Sóc

- 1 Giữ phân mềm** — dùng thuốc làm mềm phân được kê, uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất xơ để tránh rặn.
- 2 Giảm đau & vệ sinh** — dùng thuốc giảm đau theo chỉ định, rửa sạch bằng nước ấm sau khi đi vệ sinh, giữ vùng mổ sạch và khô.
- 3 Nghỉ ngơi và phục hồi dần** — tránh mang vác nặng ngoài việc bế em bé; cải thiện dần trong vài tuần.
- 4 Vật lý trị liệu sàn chậu** — giúp phục hồi sức mạnh khi vết thương bắt đầu lành.

Tái Khám & Lẫn Sinh Tiếp Theo

- Bạn sẽ được kiểm tra tình trạng lành thương và khả năng kiểm soát ruột.
- Thảo luận về **lẫn sinh tiếp theo** — nhóm chăm sóc sẽ tư vấn phương thức sinh an toàn nhất.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt, đau tăng, hoặc dịch có mùi hôi** (có thể nhiễm trùng)
- Vết thương có dấu hiệu **hở miệng**
- Rò rỉ khí hoặc phân**, hoặc mới khó kiểm soát
- Táo bón nặng hoặc không thể đi ngoài

Lưu Ý Thêm

- Ngồi thoải mái (đệm ngồi có thể giúp ích) và chườm lạnh sớm để giảm sưng.
- Không đưa bất cứ thứ gì vào trực tràng (không thuốc đặt/thụt) trừ khi nhóm chăm sóc cho phép.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Rách độ ba hoặc độ bốn (OASIS) ảnh hưởng cơ vòng hậu môn và được khâu phục hồi từng lớp ngay sau sinh.
- Giữ phân mềm, chăm sóc vết thương, và tập vật lý trị liệu sàn chậu — hầu hết phụ nữ đều hồi phục tốt.
- Báo ngay nếu có rò rỉ khí hoặc phân, sốt, hoặc vết thương hở — can thiệp sớm cho kết quả tốt hơn.